

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099848-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELVIRA NUNES FERREIRA

RECORRIDO: LEDIR NUNES FERREIRA

DIREITO À SAÚDE. RECURSO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5099848-60.2024.4.02.5101

510015384997 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099848-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ELVIRA NUNES FERREIRA

RECORRIDO: LEDIR NUNES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face do deferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 15ª VF do Rio de Janeiro [evento 42, DESPADEC1], nos seguintes termos:

*"Diante de todo o exposto, **CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA**, na forma do art. 300 do CPC e conforme fundamentação acima, para determinar que os réus, conforme suas respectivas atribuições fixadas pelo SUS (Tema 793 do STF e Lei nº 8.080/90), procedam, em máximos 30 (trinta) dias a partir da intimação da presente, à liberação e ao fornecimento à parte autora do **MEDICAMENTO RITUXIMABE 500 MG COM DOIS CICLOS (02 AMPOLAS NO PRIMEIRO DIA E 02 AMPOLAS 14 DIAS APÓS, EM CADA CICLO)**, até que sobrevenha nova decisão nos autos. O medicamento em questão deverá ser entregue na residência da parte autora, conforme endereço fornecido na inicial, a saber: **RUA MARECHAL, Nº 26 - TRAVESSA 26 - CASA 3 - REALENGO - RIO DE JANEIRO, CEP: 21.721-600 - TELEFONES: (21) 993270277 e (21) 991646952** ou, alternativamente, em outro local a ser indicado pelos réus, dentro do prazo para cumprimento, a fim de que a parte autora ou seu representante legal possam nele comparecer, para procederem à retirada do insumo requisitado."*

A União, em sede recursal, postula pela suspensão da tutela recursal, ao argumento de que existem alternativas terapêuticas eficazes, disponibilizadas pelo SUS. No mais, estaria ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a irreversibilidade da medida. Na eventualidade de ser mantida a decisão, pede que o cumprimento seja redirecionado ao Estado do Rio de Janeiro.

Indeferimento do efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelas recorridas, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

*"Em breve síntese, a autora, ora recorrida, é pessoa idosa portadora de **PÊNFIGO VULGAR GRAVE (CID L10.0)**, doença autoimune rara e grave, na qual bolhas de diversos tamanhos surgem sobre a pele e o revestimento da boca e em outras membranas, e foi submetida a tratamentos com metotrexato e corticoides, mostrando-se, entretanto, refratária a eles. Realizou dois ciclos prévios de Rituximabe em 2017 e 2021, obtendo boa resposta.*

A inicial nos autos originários foi instruída com laudo médico informando que foram usadas as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, sem, todavia, obter boa resposta. Ainda, pontua a urgência do acesso ao novo medicamento, ao argumento de que "o tratamento é necessário para controlar a doença de base e impedir mortalidade da mesma", destacando que a não utilização pode ocasionar infecção grave e óbito [evento 1, ANEXO2, fls. 12/16].

*A seu turno, o NAT-Jus informa que o medicamento **Rituximabe (500 mg)** possui registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS, através da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), apenas aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde, não sendo este o caso do pênfigo vulgar.*

Transcrevo passagens do parecer [evento 23, PARECER1]:

*"No que tange à disponibilização pelo SUS do medicamento pleiteado, insta mencionar que **Rituximabe, pertence ao grupo 1A de financiamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica2 (CEAF), é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), apenas aos pacientes que se enquadrem nos critérios de inclusão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde, bem como ao disposto no Título IV da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017 (estabelece as normas de financiamento e de execução do CEAF). Os medicamentos do CEAF somente serão autorizados e disponibilizados para as doenças (Classificação Internacional de Doenças, CID-10) contempladas no PCDT, e na legislação.***

Destaca-se que a doença da Demandante a saber, L10.0 - Pênfigo vulgar, não está dentre as contempladas para a retirada do medicamento através do CEAF, impossibilitando a obtenção do Rituximabe pela via administrativa.

O medicamento Rituximabe até o momento não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)³ para o tratamento do pênfigo vulgar".

Como se nota, a pretensão autoral traduz verdadeiro caso de uso off label.

Não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

As políticas públicas na área de saúde não incluem, via de regra, a dispensação gratuita de medicamentos para uso off label, ante expressa vedação do art. 19-T, I, da Lei 8.080/90:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

*I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (...) **(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)***

A vedação não é absoluta, sendo excepcionalmente admitida quando houver autorização do uso alternativo pela ANVISA, na forma do art. 21 do Decreto nº 8.077/2013:

Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, desde que demonstradas pela Conitec as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido na solicitação.

A possibilidade excepcional de fornecimento de fármaco para utilização off label foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da ANVISA."

STJ. 1ª Seção. PUIL 2.101-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 10/11/2021

Não suficiente, com a edição da Lei nº 14.313/2022 foi inserida expressa previsão no art. 19-T, parágrafo único, I, autorizando o fornecimento de medicamento para uso off label, desde que registrado na ANVISA e haja recomendação médica:

Art. 19-T. (...)

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)**

I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde; **(Incluído pela Lei nº 14.313, de 2022)**

Neste sentido, consta dos autos que a autora já fez uso de alternativas terapêuticas, sem sucesso, razão pela qual foi indicado o uso da **Rituximabe (500 mg)**, que, por sua vez, foi administrado pela paciente em dois ciclos, com bons resultados [evento 29, ANEXO1, autos de origem].

Verificada a excepcional possibilidade de uso alternativo ou off label, resta analisar se a parte autora demonstrou o cumprimento dos requisitos elencados no Tema 106 (REsp nº 1.657.156), em recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) *Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
- ii) *incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
- iii) *existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

A respeito do (i) **laudo médico fundamentado**, reitero que a demandante instrui a inicial dos autos de origem com formulário indicativo do uso off label da medicação pretendida, com destaque para o fato de que foram administradas alternativas sem bons resultado, ao passo que a administração da Rituximabe (500 mg) em dois ciclos foi bem sucedida.

Quanto à (ii) **incapacidade financeira de custear o tratamento**, destaco os comprovantes de renda que instruem a inicial, com indicativo de renda mensal de cerca de R\$ 2.379,49 [evento 1, ANEXO2, fls. 8], inviabilizando o acesso à medicação com valor estimado em R\$ a R\$ 9.039,08 e necessidade permanente de uso.

Já no que tange ao (iii) **registro do medicamento na ANVISA**, não paira qualquer dúvida, dada a expressa declaração do NATJUS neste sentido.

Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o **INDEFERIMENTO** do efeito suspensivo postulado."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.